השימוש הקליני בזיכרונות הילדות

מרואן דוירי[1]

מבוא

רוב התאוריות הפסיכולוגיות מדגישות את חשיבותה של הילדות בעיצוב אישיותו והתנהגותו של האדם. חלק ניכר מחוויות הילדות מתועד באופן סובייקטיבי בזיכרונות. קיימת תמימות דעים שזיכרונות הילדות אינם תיעוד אובייקטיבי-דוקומנטרי של ניסיונות העבר אלא שהם מין יצירה אישית העשויה מחומר הגלם של העבר שעברו תהליכי הכחשה, השלכה ומיסוך. במאמר זה מובאות לפניכם הקוראים הגישות של פרויד, אדלר, והגישה הנרטיבית לגבי זיכרונות הילדות, ומוצגים שלושה מקרים המדגימים את השימוש הקליני בזיכרונות. במקרה הראשון מוצג מקרה שבאמצעות זיכרונות הילדות, המטפל מנתח את תהליך ההעברה שהוא התהליך המרכזי בטיפול הפסיכואנליטי. במקרה השני מוצג אופן השימוש בזיכרונות לאבחון פסיכולוגי והערכת תכונות אופי של האנשים. במקרה השלישי מוצג מקרה של עיבוד הזיכרונות באמצעות דמיון מודרך. למרות שזיכרונות הילדות הם בעלי ערך רב מאוד בעבודה הייעוצית והקלינית, הם עדיין לא זכו למעמדם הראוי באבחון, בפסיכותרפיה ובמחקר הפסיכולוגי.

---

[1] **פרופ' מרואן דוירי**, אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

הגישות הפסיכודינמיות מצביעות על קשר בין ניסיונות העבר בילדות והמצב הנפשי בהווה, וכל אחת בדרכה מתארת איך האישיות נבנית ומתעצבת במהלך שלבי ההתפתחות על בסיס האינטראקציה בין הנתונים הביולוגיים המולדים של הילד לבין טיב הקשר עם הוריו, משפחתו וסביבתו החברתית. פרויד תיאר שלבי התפתחות פסיכו-סקסואליים שבכל אחד מהם עודף סיפוק או חוסר סיפוק יכול לגרום לקיבעון באותו שלב ולמאפייני אישיות ייחודיים.[2] אריקסון, בשונה מפרויד, מדגיש את המרכיב החברתי בהתפתחות. הוא תיאר שלבי התפתחות פסיכו-חברתיים שגם בהם חוסר האיזון במענה לצורכי הילד יכול להביא למאפייני אישיות חריגים.[3] תאוריות יחסי האובייקט שמות דגש על תהליך ההתקשרות עם הדמויות המשמעותיות, במיוחד האם, ועל תהליך האינדיבידואציה שאמור להוביל לאישיות עצמאית כאשר האם היא 'טובה דיה'. קשר שאינו 'טוב דיו', כלומר מתסכל מדי או מתירני מדי, לא נותן ביטחון ולא מאפשר אינדיבידואציה, יכול לגרום, על-פי תאוריות אלה, לפיצול (split) בתפיסת האובייקט (האם) ובעצמי ולהפרעות נפשיות.[4] גם תאוריות פסיכולוגיות שאינן פסיכודינמיות, ששמות דגש על ה"כאן ועכשיו", אינן מתכחשות לניסיון העבר אך מנסחות אותו במושגים אחרים כמו למידה (הביהביוריזם), דפוסי חשיבה (הקוגניטיביים), או עצמי (ההומניסטיים).[5]

לכאורה, הקשר בין ניסיון העבר לבין המצב הנפשי בהווה נראה חד-כיווני: העבר משפיע על ההווה. על בסיס ההבנה הזאת הוצע תהליך ההעברה (Transference) על-ידי פרויד שבו הילד מעביר את מה שלמד על עצמו ועל האחרים ואת דרכי ההתמודדות שפיתח בילדות מהעבר אל ההווה.[6] כך למשל, אדם מבוגר התלוי מבחינה נפשית באחרים, מעביר את יחסי התלות שהיו בינו לבין הוריו אל החברים, המעביד, והאישה בהווה. לעומתו אדם המגלה חרדה חברתית, מעביר את החרדה שחווה בילדות מול הוריו הביקורתיים ואולי המענישים אל הדמויות שאינן ביקורתיות ואינן מענישות בהווה. עיקר התהליך הפסיכואנליטי הוא כאשר המטפל מפרש למטופל את תהליך ההעברה על מנת שהמטופל יתפוס ויבין שהוא מתייחס לדמויות בהווה כפי שהתייחס לדמויות העבר, אף-על-פי שהוא איננו ילד עוד, והאנשים מולו אינם ההורים, ואף שונים בתכלית מההורים. תובנה זו, על-פי פרויד, אמורה לגרום לתחילתו של תהליך הסתגלות מחדש למציאות בהווה.

על-פי פרויד, העלאת זיכרונות הילדות איננה פעולה פשוטה אלא מעורבת בתהליכי הדחקה ומיסוך שגורמים לחלק משמעותי מהזיכרונות להיות מאחורי מסך של זיכרונות

---

[2] Freud, [1905]1949
[3] Erikson, 1959
[4] Mahler, Pine & Bergman, 2008
[5] Engler, 2008
[6] Racker, 2001

טפלים הקשורים בדרך כלשהי לזיכרונות המשמעותיים בלי לחשוף אותם באופן גלוי לתודעה.[7] הווה אומר שמה שמשמעותי להבנה של חוויות האדם הוא לא מה שהוא זוכר, אלא מה שהוא שכח והדחיק באמצעות זיכרונות מסך.

לעומת פרויד, תאוריות יחסי האובייקט טוענות שהתנהגות האדם בהווה איננה רק העברה טהורה ועיוורת מהעבר אל ההווה, אלא שהיא מושפעת גם מתנאי ההווה ומוסברת גם על ידם. כך למשל חרדה חברתית יכולה להיגרם גם כתוצאה מתהליך העברה מניסיון העבר אל ההווה, יחד עם ביקורת ועניישה שמתרחשות בהווה ומעוררות את החרדה: בכיתה, בעבודה ובחיי הנישואין. במילים אחרות, ההעברה מתקיימת כשיש לה הצדקה גלויה או סמויה בהווה, אך כשהאדם עובר חוויה מתקנת חדשה שבה הוא מזהה שהאנשים בסביבתו אינם מאיימים או מפנקים כמו הוריו, אלא 'טובים דיים' (Good enough), תהליך ההעברה אמור לדעוך ומתחיל תהליך של שינוי בתפיסת העצמי והאחר ושינוי בהתנהגות של היחיד.[8]

אדלר הצביע על מורכבות נוספת בהבנת הקשר בין זיכרונות העבר לבין האישיות בהווה. לטענתו, זיכרונות הילדות אינם מביאים חומר על העבר המלמד על האישיות בהווה בלבד, אלא הם נבחרים באופן סלקטיבי בהתאם לאישיות העכשווית. דהיינו ההווה משפיע על תוכן הזיכרונות המועלה מהעבר. לטענתו, לאחר שנת החיים הרביעית או החמישית, לכל אחד יש סגנון חיים (מבנה אישיות) המבוסס על תפיסת העצמי, תפיסת האחר, העצמי האידיאלי וערכים. בהתאם לסגנון החיים שלו, היחיד מטמיע, מיישם ומעכל את הנתונים על חוויות החיים: "הוא לוקח מהנתונים האלה רק אותן מסקנות שיתאימו לסכמת האפרספציה המבוססת שלו".[9] טענתו של אדלר היא שהאדם מעלה זיכרונות למודע שמתאימים לסגנון החיים העכשווי ומצדיקים אותו, כך שהזיכרונות מהווים דגימה מייצגת לניסיונו באירועי העבר המעצבים את סגנון החיים בהווה. בדרך זו הוא מוצא את זרעי סגנון החיים בזיכרונות הילדות הכוללים את תפיסת העצמי, תפיסת העולם ואת דרך ההתמודדות שהוא פיתח לעצמו. אדלר טוען שהזיכרונות משרתים את מטרת האדם בחיים: הם יכולים להזהיר, לנחם, לעודד, לכוון, או להכינו לקראת העתיד. דהיינו, אנו בוחרים באופן סלקטיבי, במודע או לא במודע, את הזיכרונות המשרתים את המטרה שלנו בחיים ומשמיטים זיכרונות שלא משרתים את המטרה. לדוגמה: כדי לשרת את מטרת 'העליונות' של היחיד, סגנון החיים שלו יכלול תפיסת עצמי של "אני חזק מכולם" ו/או תפיסת האחרים של "משפילים אותי".

---

[7] Freud, [1915-1916]1981

[8] Winnicott, 1971

[9] Adler, [1931]1964: 122

אדם העובר שינוי משמעותי בחייו, כמו הגירה או נישואין, בדרך כלל ינהל את חייו על-פי סגנון החיים שנבנה במהלך חייו. במידה וסגנון החיים אינו משרת את מטרותיו הוא מגיע למבוי סתום המחייב שינוי בסגנון החיים ואז, על-פי אדלר, הוא חייב לנסח מחדש את נרטיב חייו ולהתחבר לזיכרונות חדשים שיעזרו לו יותר עם האתגרים החדשים שמולם הוא ניצב. דבר דומה קורה כאשר אדם עובר פסיכותרפיה המשנה את תפיסתו את עצמו, את האחר, את העולם ואת דרכי ההתמודדות שלו. על כן הוא צפוי, על-פי אדלר, להבנות את הנרטיב מחדש ולהתחבר עם זיכרונות חדשים או לנסח מחדש את הזיכרונות הקודמים.[10]

כאן מתגלה תפיסה שונה של אדלר לעומת תפיסתו של פרויד לגבי זיכרונות הילדות: אומנם שניהם מדגישים את הסלקטיביות בבחירה ובהבניה הסובייקטיבית של הזיכרונות ושניהם לא מייחסים לזיכרונות ערך של אמת מתועדת, אך פרויד רואה בזיכרונות כמסך המחפה על תהליך ההדחקה של החוויות המשמעותיות בילדות, ואילו אדלר רואה בזיכרונות הילדות חומר המכיל את אבני היסוד של סגנון החיים של היחיד בהווה המשרתים את מטרותיו בחיים, וטוען שכל שינוי אישיותי כתוצאה מאירועים טראומטיים בחיים או כתוצאה מפסיכותרפיה אמור לדגום, לארגן ולנסח את הזיכרונות מחדש כך שיתאימו לשינוי באישיות.

הגישה הנרטיבית[11] לקחה את רעיון ההקבלה בין הזיכרונות לבין האישיות צעד נוסף קדימה וטענה ששינוי, הרחבה, או ניסוח מחדש של הזיכרונות, יש ביכולתם לשנות את המצב הנפשי של היחיד בהווה. וכך הטיפול הנרטיבי מבוסס על ניסוח הנרטיב האישי מחדש. על-פי גישה זו הנרטיב המורכב מזיכרונות סלקטיביים וממה שנאמר על היחיד בילדותו מבני המשפחה או דמויות משמעותיות אחרות, אומר לנו מי אנחנו ומי האחרים. ניסוחו של הנרטיב מבוסס על זיכרונות עבר מתאימים קובע את תפיסתנו, רגשותינו, והתנהגותנו בהווה. אם בעבר אדם אימץ לעצמו דימוי עצמי של 'עצלן' בעקבות התנהגות עצלנית ו/או אמירות של אחרים עליו, הוא יהיה ערני ומודע להתנהגותו העצלנית בהווה ויראה בה אישור לנרטיב שלו, כשהוא מתעלם או מפחית מערכן של התנהגויות "לא עצלניות" ויתייחס אליהן כאירועים חריגים. בטיפול הנרטיבי, המטפל יחד עם המטופל בונים את הנרטיב מחדש כך שיכלול את מכלול התנסויותיו בעבר ובהווה (לדוגמה זיכרונות של עצלנות וגם חריצות). במילים אחרות, הם מנסחים את העבר מחדש וכך הניסוח החדש גורם לשינוי בזהות, בתפיסת העולם, בערכים, ברגש, ובהתנהגות של המטופל.[12]

ובכן, הזיכרונות שלנו אינם תיעוד פוטוגרפי אובייקטיבי של אירועי החיים, אלא הם יצירה סובייקטיבית אישית הנבנית באופן סלקטיבי מחומרים מן העבר המתאים לאישיות

---

10 Adler, [1931]1980

11 White & Epston, 1990

12 White & Epston, 1990; Brown & Augusta-Scott, 2007

בהווה תוך הבלטה, הכחשה ומתן משמעויות אישיות לחומר הגולמי של העבר. בנוסף, הזיכרונות הם גם דינמיים ומשתנים בהתאם למצבנו הנפשי בשלבי החיים השונים. אפילו, עצם שיתופו של אדם אחד בזיכרון שאנו מעלים מהעבר, עשוי להיות מעורב בתהליך רקונסטרוקציה של הזיכרון ולשנות אותו.[13]

במאמר זה אציג בקצרה שלושה מקרים על מנת להמחיש את השימוש הקליני בזיכרונות לצורך הבנה, אבחון וטיפול פסיכולוגי.

השימוש בזיכרונות לצורך הבנת תהליך ההעברה וניתוחו

עימאד[14] הוא בן בכור למשפחה המורכבת מאב מורה, אם עקרת בית, שני אחים ושתי אחיות. הגיע לטיפול בגיל 19 בגלל דיכאון המאופיין בעצב ממושך, בדידות, ירידה בתפקוד בלימודים, הימנעות מקשרים עם בני משפחתו וסביבתו החברתית ומחשבות אובדניות. לדברי בני המשפחה, עד כיתה ו' היה תלמיד מבריק ומצטיין ו"מלא חיים", אך מצבו החל להידרדר במהלך חמש השנים האחרונות. למרות זאת הוא שומר על הישגים טובים ומתמיד בקורס הכנה למבחן הפסיכומטרי.

בתחילת הטיפול הוא סיפר, עם הרבה כאב ודמעות, כמה הוריו הזניחו אותו, לא הגנו עליו מפני עוינות מצד צעירי המשפחה ותלמידי הכיתה ודחו אותו לעומת אחיו השני שכל מה שעשה זכה להערכתם. הנה כמה דוגמאות מייצגות של הזיכרונות שהעלה:

> בגיל 11 בערך, תוך כדי משחק עם בן הדוד שלי הוא קילל אותי, אז כעסתי וירקתי עליו. הוא הלך להתלונן, ואז אמא שלי קראה לי ונזפה בי בפני כולם. ניסיתי להסביר לה אך היא לא שמעה. הרגשתי שהיא לא מבינה אותי ורק עסוקה בלרצות את הדוד ואת משפחתו. כעסתי ונכנסתי לחדר שלי ובכיתי הרבה.
>
> בכיתה ט' בני הכיתה התלוצצו על מבנה גופי השמן. [הם] עשו זאת כל יום. המורה ראה ולא עשה כלום ואף הצטרף אליהם בצחוק. למרות שהייתי מצטיין, התעלמו מהישגיי וראו רק את מבנה גופי. סיפרתי להורים אך לא עשו דבר גם הם. אמרו לי "אמרנו לך לשמור על המשקל שלך". הרגשתי בודד ועצוב. באותה תקופה התחלתי להתרחק מהמשפחה ומהילדים בכיתה ולהיות בודד.
>
> לפני שבוע ביקשתי מאימא שתבשל ממולאים. [היא] ענתה בקוצר רוח שהיא עייפה ואין לה זמן. שלשום היא הכינה ממולאים. בהתחלה שמחתי, אחר כך הבנתי שהיא הכינה אותם לאחר שהאח שלי ביקש ממנה לעשות לו ממולאים.

על פניו הזיכרונות מאמתים ואף מצדיקים את מצבו הנפשי הנוכחי: עימאד מרגיש דחוי ורואה שסביבתו עוינת ולא אמפתית כלפיו. ניסיונותיו לגרום שיבינו אותו ויעזרו לו לא צלחו, לכן החל לסגת ולהתרחק ממגע עם הרבה עצב, תסכול וכעס.

---

[13] Sacchi, Agnoli & Loftus, 2007

[14] השמות המופיעים במאמר בדויים.

הוא עבר טיפול אינטגרטיבי שכלל שילוב של קבלה בלתי מותנית, יישום עקרונות החוויה המתקנת, ניתוח ההעברה, ושילוב טכניקות הטיפול הקוגניטיבי (CBT). במהלך ניתוח תהליך ההעברה ופירושה ובמהלך תיקון המחשבות והאמונות הפנימיות הלא רציונליות ולא פונקציונליות שלו, עימאד נהיה מודע לכך שהוא מתנהג היום, בגיל 19, מול ההורים והסטודנטים בקורס הפסיכומטרי על-פי אותן תפיסות שאימץ לעצמו בגיל 11: "אני דחוי" ו"הסביבה עוינת", בלי לפקוח עיניים ולבדוק את תוקף התפיסות בהווה, ובלי לבחון כלים ודרכי התמודדות חדשות שלא היו לו בילדותו ושיש לו היום כבחור בן 19 שנים.

עם התקדמות הטיפול, חל שינוי בהערכה העצמית ובתפיסת העולם שלו. התחילה להתגלות תמונה יותר רחבה של חייו והוא החל להביא זיכרונות מסוג אחר. הנה זיכרון שהביא במהלך המעבר מסגנון חיים של "דחוי" לסגנון של "אני בעל ערך":

> אימא שלי הראתה לי השבוע סרטון וידאו ישן ממסיבת סיום השנה בגן. אבל אני לא זוכר מה היה במסיבה, רק ראיתי בווידאו שאני נושא על במה קטנה מילות תודה לקהל ההורים והילדים וכולם שמחים ומוחאים לי כפיים. האמת שאני לא מאמין שזה באמת קרה. רק ראיתי אותו בסרטון.

אומנם בהתחלה, זה היה עם מידה מסוימת של הסתייגות ואף הכחשה כפי שראינו בזיכרון הקודם, אך לאחר מכן עימאד העלה זיכרונות יותר ברורים שהוא ממש זוכר אותם ברמת החוויה האישית הישירה:

> אני זוכר שהמורה למתמטיקה בכיתה ג' היה מזמין אותי להסתובב יחד איתו בכיתה כדי לעזור לילדים בפתרון השאלות ולתקן להם את הטעויות. באותה תקופה הרגשתי שאני מוערך ואהוד מאוד [...] אני זוכר שהייתי מאוד פופולרי ומצטיין בכיתה.

לקראת סוף הטיפול נבנה נרטיב חדש אך לא חד-גוני: כבן בכור במשפחה ערבית הוא זכה לתהילה מיוחדת, פינוק והיענות לא מוגבלת לכל צרכיו. עם לידת האח השני לאחר חמש שנים הופיעו ביטויי קנאה שהתבטאו בעוינות כלפי האח ובהתנהגות מתנגדת להורים. יחס ההורים החל להשתנות והם החלו לנקוט בשיטות ענישה מילולית ולעיתים פיזית ויחסם הפסיק להיות אוהד. התנהגותו, שבאה להגן על מקומו במשפחה, הביאה לתוצאות הפוכות מאלה שהוא רצה בהן. במהלך השנים סגנון החיים שלו השתנה: עד גיל 10 בערך הוא שמר על סגנון של "אהוד" שסביבתו אוהבת אותו ללא תנאים, לאחר מכן הוא אימץ סגנון חיים של "דחוי" כאשר סביבתו החברתית לא אהבה אותו. אז חלה ירידה בהישגיו, משקלו עלה, דבר שהביא באמת ליחס עוין ודוחה מסביבתו החברתית בבית ובבית הספר. מאז הוא אוגר זיכרונות המעידים ומצדיקים סגנון חיים של "דחוי".

המקרה הזה מזכיר דוגמה אחרת שאדלר הביא ובה הוא אומר שאם מטרת העליונות של היחיד דורשת שירגיש שאנשים אחרים משפילים אותו, הוא יבחר לזכור אירועים, שאותם יכול לפרש כהשפלות.[15] כמו כן, הוא מדגים באופן ברור את הבחירה הסלקטיבית של הזיכרונות שיתאימו למצב הנפשי הנוכחי ומדגים כיצד הטיפול, גם אם הוא לא טיפול נרטיבי, מסתיים בנרטיב חדש ושונה עם דימוי עצמי ותפיסת עולם שעוזרים למטופל להסתגל ולהתמודד יותר טוב עם קשיי החיים.

הזיכרונות ככלי אבחון

על סמך הספרות הענפה, בין היתר של פרויד ושל אדלר,[16] המראה את ההקבלה בין הזיכרונות לבין המצב הנפשי והאישיות העכשוויים, ניתן לטעון שיש בזיכרונות פוטנציאל לאבחון תכונות אופי ו/או הפרעות נפשיות. באחד משיעורי הסמינריון על זיכרונות שלימדתי בתוכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, הסטודנטיות בדקו בהנחייתי טענה זו. חלק מהסטודנטיות בחרו לבדוק בזיכרונות את השתקפותה של תכונת אופי מסוימת כגון, נפרדות נפשית, ביטחון עצמי או אסרטיביות, וחלק אחר בחרו לבדוק בזיכרונות השתקפות של הפרעה נפשית מסוימת כגון חרדה, אנורקסיה או דיכאון.

כל אחת חילקה שאלון הבודק את תכונת האופי או את ההפרעה שרצתה לחקור ל-20 נבדקים מבוגרים. מתוכם נבחרו שני הנבדקים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בסולם כמייצגים את הנבדקים בעלי תכונת האופי הנחקרת (כמו נפרדות נפשית גבוהה), או ההפרעה הנחקרת (כמו דיכאון). כמו כן נבחרו שני הנבדקים שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר בסולם כמייצגים את הנבדקים שאין להם את תכונת האופי הנחקרת (בעלי נפרדות נפשית נמוכה), ושאין להם את ההפרעה הנחקרת (כמו דיכאון).

לאחר שבחרו את הנבדקים משני הקצוות הן אספו מכל אחד/ת שלושה זיכרונות ילדות ובדקו את השתקפות תכונות האופי או ההפרעה בזיכרונות. הממצאים מראים שתכונות האופי או ההפרעות שנחקרו ואובחנו על-פי כלי אבחון (השאלון) השתקפו בזיכרונות של הנבדקים שקיבלו ציונים גבוהים וכמעט ולא השתקפו בזיכרונות שקיבלו ציונים נמוכים. במסגרת הצגת הרפרטים בכיתה, הזיכרונות של כל נבדק/ת הוצגו בכיתה לאחר תיאור תכונת האופי או ההפרעה הנחקרת, אך בלי להצהיר אם הנבדק/ת קיבל/ה ציון גבוה או נמוך. הסטודנטיות בכיתה התבקשו לנחש על-פי הזיכרונות האם מדובר בנבדק/ת בעל/ת ציון גבוה או נמוך. שיעור הקליעה של הסטודנטיות היה בין 80% ל-90% מהמקרים. למרות שניחושן של הסטודנטיות אינו עדות מחקרית מקובלת, ייתכן שהיותן סטודנטיות לתואר שני בייעוץ חינוכי, מאפשר לראות באחוז הניחוש הגבוה שלהן עדות חזקה לכך

[15] Adler, [1931]1980
[16] שריג, 2016

שהזיכרונות מהווים כלי אבחון בעל תוקף גבוה מאוד בניבוי תכונת האופי או ההפרעה הנפשית.

קצרה היריעה במאמר זה ולא אוכל להציג בו את כל הממצאים, לכן אסתפק כהמחשה להציג זיכרון כדוגמה של נבדק דיכאוני לעומת זיכרון של נבדק לא דיכאוני.

לצורך איתור הנבדקים עם הדיכאון הועבר שאלון של בק ועמיתיו[17] לבדיקת דיכאון ל-20 נבדקים מתנדבים. השאלון מוכר ונפוץ מאוד והוא בודק 21 מאפייני דיכאון שהם: עצב, פסימיות, תחושת כישלון, היעדר הנאה, רגשי אשמה, תחושת עוול ועונישה, הערכה עצמית שלילית, ביקורתיות עצמית, מחשבות אובדניות, בכי, מתח, היעדר עניין, היסוס בקבלת החלטות, ערך עצמי נמוך, היעדר אנרגיה, הפרעות שינה, נטייה לכעס, היעדר תיאבון, קשיי ריכוז, עייפות וירידה בתשוקה המינית.

מתוך 20 הנבדקים נבחרו כאמור המשתתפים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר ואלה שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר. להלן זיכרון לדוגמה של נבדקת דיכאונית וזיכרון לדוגמה של נבדקת לא דיכאונית.

זיכרון של נבדקת דיכאונית בת 38 עם ציון 52 בשאלון בק:

> בכיתה ה' עברתי ללמוד בבית ספר חדש. לא הכרתי אף אחד שם. כל החברות שהיו לי קודם נשארו בבית הספר הקודם. לא רציתי לעבור לבית הספר החדש אך לא יכולתי לשכנע את ההורים והם העבירו אותי בניגוד לרצוני בגלל שהם הסתכסכו עם מנהל בית הספר הקודם. אני זוכרת שבימים הראשונים כל בוקר הייתי בוכה. בבית הספר הרגשתי בודדה ודחויה וחסרת אונים. לא ידעתי מה לעשות ואיך להתחבר לבנות שם. לא ידעתי למי לפנות. לא היה לי כוח ללמוד ולעשות שיעורי בית, הציונים שלי ירדו. התביישתי בציונים שלי. כשראיתי את אי-שביעות רצונה של אימא שלי מהציונים שלי בטרימסטר הראשון הרגשתי רע. היא לא אמרה לי כלום אך הבנתי את המסר ושנאתי את עצמי שלא שמרתי על הישגים טובים. השנה ההיא הייתה קשה מאוד וכל הזמן הייתי ללא מצב רוח.

הזיכרון מציג תמונה של ילדה חסרת אונים, עצובה, בעלת דימוי עצמי שלילי ורגשי אשמה, עם ירידה בתפקוד ובמצב הרוח. בלוח 1 המופיע בהמשך מוצגים ציטוטים מתוך הזיכרון המתאימים למאפייני הדיכאון על-פי השאלון בק.

זיכרון של נבדקת לא דיכאונית בת 43 עם ציון 9 בשאלון בק:

> הילדות שלי הייתה מאושרת. לא שההורים נתנו לי את הכל. להפך, אני הייתי הבת השנייה. אחותי הבכורה הייתה המלכה בבית. אני הייתי טובה יותר ממנה בבית הספר וגם היה לי קול יפה. במסיבות בית הספר היו מבקשים ממני לשיר מול כל ההורים. ביקשתי ללמוד לנגן על כינור. בהתחלה ההורים התעלמו מבקשתי אך

[17] Beck et al., 1961

המשכתי לנדנד להם עד שהביאו לי את הכינור. לקחתי כמה שיעורי נגינה אחר כך המשכתי לבד ולמדתי לאלתר מנגינות שאהבתי. אחותי קינאה והרבתה להתלונן עליי, אך אני ידעתי להגן על עצמי. פעם היא לבשה את החולצה החדשה שלי אך אני התנגדתי. אימא התערבה. התעקשתי ובכיתי ואילצתי אותה להחזיר את החולצה לארון. לא שהייתי רעה אך היא כל הזמן לא הרשתה לי לגעת בשום דבר שלה. כן, היו הרבה מתחים בינינו ולפעמים לא ידעתי מה לעשות, אבל הסתדרתי.

התמונה בזיכרון היא של ילדה גאה בעצמה ובכישוריה, יודעת להגן על עצמה, עקשנית ועומדת על שלה ומצליחה להשיג את מבוקשה. בטבלה ניתן לראות שלא היו לה את 17 אפיוני הדיכאון, ואף היו סימנים מנוגדים לדיכאון, פרט לארבעה שגם הם לא חמורים במיוחד.

לוח 1: **משפטים בזיכרונות של נבדקת דיכאונית ונבדקת לא דיכאונית המתאימים למאפייני הדיכאון על-פי בק**

מאפייני דיכאון לפי בק	נבדקת דיכאונית (ציון 52)	נבדקת לא דיכאונית (ציון 9)
עצב	"כל בוקר הייתי בוכה"; "הרגשתי רע"; "ללא מצב רוח"	
פסימיות		
תחושת כישלון וחוסר אונים	"לא יכולתי לשכנע את ההורים"; "לא ידעתי מה לעשות"; "חסרת אונים"; "לא שמרתי על הישגים טובים"	
היעדר הנאה	בזיכרון לא הצביעה על שום דבר מהנה	
רגשי אשמה	מול תגובת האם "התביישתי"; "הרגישה רע"; "שנאה את עצמה"	
תחושת עוול ועגמה	"הם העבירו אותי בניגוד לרצוני בגלל שהסתכסכו עם מנהל בית הספר"	"אחותי הבכורה הייתה המלכה"; "היא כל הזמן לא הרשתה לי לגעת בשום דבר שלה"
עמדה שלילית כלפי העצמי	"שנאתי את עצמי"; "התביישתי"	
ביקורתיות עצמית	"שנאתי את עצמי שלא שמרתי על הישגים טובים"	
מחשבות אובדניות		
בכי	"בכיתי"	"התעקשתי ובכיתי"
מתח	"הרגשתי רע"	"היו הרבה מתחים בינינו"
היעדר עניין	"ללא מצב רוח"	
היסוס בקבלת החלטות	"לא ידעתי מה לעשות ואיך	"לפעמים לא ידעתי מה

מאפייני דיכאון לפי בק	נבדקת דיכאונית (ציון 52)	נבדקת לא דיכאונית (ציון 9)
	להתחבר לבנות שם"; "לא ידעתי למי לפנות"	לעשות"
ערך עצמי נמוך	"התביישתי בציונים שלי"	
היעדר אנרגיה	"לא היה לי כוח ללמוד ולעשות שיעורי בית"	
הפרעות שינה		
נטייה לכעס		
היעדר תיאבון		
קשיי ריכוז		
עייפות		
ירידה בתשוקה המינית		
סה"כ	**13 אפיוני דיכאון**	**4 אפיוני דיכאון**

שני הזיכרונות מראים בבירור איך הדיכאון שאותר בשאלון של בק ועמיתיו משתקף בזיכרון של הנבדקת הראשונה, ואילו הזיכרון של הנבדקת השנייה, הלא דיכאונית, נותן תמונה הפוכה מהדיכאון, דבר המעיד על כך שהזיכרונות יכולים להיות כלי אבחון לתכונות אופי ולהפרעות נפשיות.

עיבוד הזיכרונות באמצעות דמיון מודרך

עד כה ראינו את הערך של הזיכרונות בהבנת ההעברה וניתוחה ובאבחון של המקרים. עתה אדגים את עיבוד הזיכרונות באמצעות דמיון מודרך[18] במטרה לגרום לשינוי משמעותי במצב הפסיכולוגי של המטופלת. במודל הביו-פסיכו-סוציאלי של פסיכותרפיה[19] אני מבהיר איך הדמיון המודרך מקרין על הרמה הביולוגית, הפסיכולוגית והבין-אישית של המטופל. על בסיס ההבנה שכל זיכרון או נרטיב הוא בעצם יצירה דמיונית שנבנתה מחומר העבר בהתאם למצב הפסיכולוגי בהווה, אפשר להניח ששינוי מודרך ביצירה באמצעות דמיון מודרך יגרור אחריו שינוי בחוויה הגופנית, הפסיכולוגית והחברתית.

אציג כאן בקצרה דמיון מודרך של מייסון, מורה בת 28 הסובלת מחרדה חברתית וחוסר ביטחון עצמי. היא סטודנטית מצליחה לתואר שני ונמצאת בקשר עם בחור אוהב ותומך. לאחרונה מנהל בית הספר הציע למנותה לתפקיד מחנכת כיתה אך היא נרתעה מהתפקיד בגלל החרדה וחוסר הביטחון. מאז היא מדווחת על מיחושים גופניים המעידים על חרדה ולחץ כמו קוצר נשימה, דופק מהיר, ירידה בתיאבון ונדודי שינה.

בשיחות הטיפוליות היא מתארת את עצמה היום כמצליחה, אהובה ואהודה אך עדיין בתוכה קיימת תחושה של כישלון, דחייה וחוסר ביטחון שאינם מוסברים על-פי המציאות

[18] Kosslyn, 1980, 1987; Kosslyn, Thompson & Ganis, 2006

[19] Dwairy, 1997, 2013

היום. כשביקשתי שתספר לי על זיכרונות ילדותה סיפרה על כמה זיכרונות שמתברר שהם קשורים לחרדה ולמיחושים הגופניים המתלווים לחרדה.

זיכרון ראשון:

> אני זוכרת, אימא נתנה לי לגן סנדוויץ' חביתה ובצל. אהבתי את החביתה עם בצל. בזמן הארוחה הגננת שאלה בקול רם עם פרצוף של נגעלת, מאיפה הריח הזה של ביצים. התביישתי והסתרתי את הסנדוויץ'. נשימתי נעצרה והרגשתי חנק. הבנות שלידי צחקו עליי בשקט ללא קול. לא אכלתי באותו יום. בהפסקה הבנות לעגו לי ואמרו: "מימי (אז קראו לי מימי) הביאה סנדוויץ' מסריח". כשחזרתי הביתה אימא שאלה אותי למה לא אכלתי את הסנדוויץ', אמרתי לה שאני לא אוהבת חביתה ובצל. [היא] הביעה תמיהה ושתקה.

זיכרון שני:

> אני זוכרת שבכיתה ג' הבנות עשו עליי חרם. כולן התרחקו ממני. לא העזתי להשתתף בשיעורים למרות שבמבחנים תמיד קיבלתי 100. בהפסקות ישבתי בכיתה לבד בעוד שכולן יצאו לשחק בחצר. כמה פעמים אכלתי את הסנדוויץ' בשירותים של בית הספר כדי שאף אחד לא יראה אותי.

מייסון סיפרה על זיכרונות נוספים של דחייה שקשורים לחוסר הביטחון העצמי. בין היתר היא דיווחה על כך שבכיתה י' היא התאהבה 'מרחוק' בתלמיד בכיתה שהיה יפה ומבריק וכולם אהבו אותו ורצו אחריו. היא שמרה את אהבתה בסוד ולא הביעה שום סימן או איתות לרגשותיה בשל החשש מפני דחייה. לאחר שסיימו את התיכון היא שמעה מחברה שלה שאותו בחור העריך אותה ודיבר עליה דברים חיוביים, אך כיבד את בחירתה להיות מרוחקת מהחברים בכיתה.

במהלך הטיפול המטפל מסביר לה ומפרש כיצד למרות ההצלחה בלימודים ובעבודתה כמורה, ההערכה שהיא זוכה לה ממנהל בית הספר, והאהבה שהיא זוכה לה מהחבר שלה היום, היא עדיין מרגישה את עצמה כפי שהרגישה בכיתה מול המורה שדחתה אותה והבנות שהחרימו אותה. המטפל מנסח עבורה את תהליך ההעברה במונחים של 'מייסון המורה' בת ה-28 שמרגישה את עצמה כמו "מימי בגן" ומגיבה בדרכים של מימי הנמנעת והנחנקת. במהלך הטיפול המטופלת הבינה שבתוכה עדיין פועלת ישות של ילדה קטנה עם חרדה וחוסר ביטחון עצמי, ואז מתחיל שלב הדמיון המודרך.

הבאת מייסון המורה לעבר: המטפל מבקש ממנה לעצום את העיניים ולדמיין את מימי, אותה ילדה בגן באותו יום שבו הגננת הביעה גועל מהכריך שלה. הוא מדריך אותה לדמיין את הזיכרון באופן מוחשי בעזרת כל החושים: לראות את המקום, את הגננת ואת הבנות, לשמוע את קול הגננת והצחקוקים של הבנות, להריח את הריחות, לחוש את תחושות החנק. לאחר שהיא מאותתת עם נדנוד ראש קל שהיא 'בתוך' הסצנה הזאת, הוא

מציע לה לדמיין את 'מייסון המורה' מופיעה בסצנה. הוא מבקש ממנה לפתח את התסריט ולדמיין איך הסצנה מתפתחת בנוכחות 'מייסון המורה'. המטופלת נושמת עמוק ומתחילה לפתח את הסצנה ולספר כשעיניה עדיין עצומות. היא מתארת באופן מוחשי חיבוק בין מייסון ומימי, ומדווחת על מילות עידוד למימי, ומתארת איך מימי מוציאה את הסנדוויץ' ואוכלת כשהיא עטופה בזרועה של מייסון. היא אף עונה לגננת שהיא אוהבת את החביתה עם בצל למרות הצחקוקים של הבנות. במהלך פיתוח הדמיון שנמשך כמה דקות, שפת הגוף של מייסון משתנה ומעידה על רוגע וחיוך קל מופיע על פניה.

לאחר סיום שלב הדמיון מתנהלת שיחה עם המטפל על החוויה הפנימית שמייסון עברה במהלך הדמיון שבה מבינים שנוכחות מימי הילדה במחשבותיה, רגשותיה ותגובותיה של מייסון הפכה להיות יותר מודעת ומוחשית. לאחר מכן ממשיכים בדמיון מודרך בזיכרון של החרם בכיתה ג'. בשלב פיתוח הדמיון בנוכחות מייסון ומימי היא מדווחת על חיבוק ועידוד של מימי ועל כך ששתיהן יוצאות לחצר כשמימי אוכלת את הסנדוויץ' ושתיהן משוחחות על הגננת הדוחה ומעלות זיכרונות על "הגועל" של הגננת ושתיהן צוחקות. לאחר מכן היא מדווחת על עוד בנות בחצר שיושבות או מסתובבות לבד. אחת מהן מתקרבת ומתעניינת בצחוק שלהן ואז מימי מספרת לילדה על הגננת ואז הילדה מתחילה לשתף על חוויות דומות משלה באווירה של צחוק על מה שהיה.

בשיחה שהתנהלה לאחר מכן על הדמיון, המטופלת נהייתה מודעת יותר ויותר לקיום ישותה של הילדה מימי בתוכה ומודעת לצורך של מימי בתמיכה. לאחר סיום אותה פגישה, המטפל הנחה את מייסון להמשיך במתן תשומת לב למימי הנוכחת יחד אתה בכל מקום. הוא הנחה אותה לצאת מהפגישה יחד איתה, ללוות אותה הביתה, להמשיך להקשיב לעוד זיכרונות שהיא זוכרת ולתת לה להכיר את 'מייסון המורה' עם ההצלחות שלה היום בלימודים, בעבודה ובקשר עם החבר.

הבאת מימי הילדה לחיי מייסון בהווה: בפגישה הטיפולית לאחר כשבוע, המטופלת דיווחה על שיפור והקלה במצבה ועל היכרות יותר ברורה ומוחשית עם מימי הילדה. הפעם המטפל מציע לה דמיון מודרך שבו מימי הילדה מופיעה באופן מוחשי בחיי מייסון בהווה: הוא מבקש מהמטופלת לעצום עיניים ולהתחבר עם עצמה כאן ועכשיו. המטפל מציע לה את הסצנה הדמיונית הזאת:

> בסוף השבוע את קמה בבוקר עם מצב רוח טוב, מזג האוויר יפה כמו שאת אוהבת, כולם כבר יצאו מהבית ואת לבד ואין לך תוכניות. את מכינה לך את הקפה שלך ויושבת על הספה בבית. לאחר דקות את שומעת דפיקות קלות בדלת. את לא מחכה לאף אחד. את קמה ופותחת את הדלת ואת רואה להפתעתך את מימי כפי שהכרת אותה עומדת מולך. היא באה בעצמה אליך. את ממש מזהה אותה עם הבעות הפנים, הלבוש, מבנה הגוף. עכשיו את תמשיכי את הסצנה. תארי מה יקרה.

המטופלת לוקחת את השרביט וממשיכה לפתח את הסצנה: מייסון מתכופפת ומחבקת אותה, ממששת אותה, שתיהן מתחבקות חזק ובוכות בכי של געגועים, לוקחת אותה ביד פנימה. מראה לה את הבית מבפנים. מכינה לה תה וארוחת בוקר של חביתה ובצל. הן משוחחות על זיכרונות משותפים ומגוונים שהיו להן במשפחה, בלימודים ובעבודה. שתיהן מרגישות שהן מכירות אחת את השנייה ומרגישות מחוברות אחרי תקופה ארוכה של נתק. שתיהן מבטיחות שלא יתנתקו עוד לעולם.

כבר במהלך הדמיון המודרך ניתן לראות סימני הקלה שבאים לידי ביטוי בהבעות הפנים, בנשימה ובתנוחת הגוף. לאחר סיום הסצנה מייסון מתארת חוויה של "לידה מחדש" שבה היא מרגישה רוגע, ביטחון עצמי ואושר. המטפל מסביר לה שהתחושה הזאת אינה דמיונית אלא המחשה אמיתית הן לחוויה הסובייקטיבית הפנימית שכוללת את חוויות הדחייה בעבר כשהייתה הילדה קטנה וחלשה מול האחרים, והן לחוויות ההצלחה והקבלה שהיא חווה היום.

זה היה תיאור של שתי פגישות דמיון מודרך שהן חלק מתהליך טיפולי משולב הכולל אלמנטים תמיכתיים, קוגניטיביים ופסיכודינמיים שהביא להקלה משמעותית בחרדה ולשיפור הביטחון העצמי.

הבסיס התאורטי של העבודה בדמיון טמונה בהבנה שהחוויה האנושית בסופו של דבר היא חוויה פנומנולוגית סובייקטיבית, ובהיותה כך, ההתערבות דרך הדמיון אמורה להשפיע באופן אמיתי על החוויה האמיתית לא פחות, ולעיתים אף יותר מכל שינוי מוחשי או עובדתי. עצם הבניית הזיכרון מחדש הביא לשינוי בתפיסה, בדימוי עצמי, בחשיבה, ברגש ובתחושות הגוף, כמו גם להקלה בחרדה ולשינוי התנהגותי מול האנשים.[20]

סיכום

הזיכרון הוא נקודת החיבור בין המצב הנפשי בהווה לבין ניסיון העבר. היות וכל התאוריות הפסיכולוגיות, כולל אלו המדגישות את ה"כאן ועכשיו" מסכימות שהעבר נוכח בהווה, באופן מודע או לא מודע. זאת באמצעות זיכרונות, למידה ודפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות והעצמי. על כן העבודה עם הזיכרונות מהווה מרכיב חשוב במגוון של טיפולים. הזיכרונות משמשים לניתוח ההעברה שהוא הכלי המרכזי בפסיכואנליזה שדרכו המטופל נהיה מודע לתכנים לא מודעים ונעזר כך בדרך התמודדותו עם קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, דבר אשר מביא הקלה בסימפטומים ושינוי במחשבות, ברגש ובהתנהגות כפי שראינו במקרה הראשון של עימאד. הם גם יכולים להיות כלי עזר באבחון הפרעות נפשיות או תכונות אופי אישיותיות כפי שראינו במחקרן של הסטודנטיות בסמינריון. לכן מומלץ לכלול את

[20] Dwairy, 1997, 2013

הזיכרונות בסוללת האבחון הפסיכולוגי. הזיכרון יכול לשמש חומר חשוב בעבודה באמצעות דמיון מודרך המארגן מחדש את הקשר בין הילד/ה שבתוכנו לבין המבוגר/ת, דבר שגורם לשינוי משמעותי במצב הנפשי של המטופלת, כפי שראינו במקרה של מייסון.

כמובן שהשימוש בזיכרונות מצריך מומחיות מיוחדת בהיותו כלי הנתון לפרשנות סובייקטיבית של המטפל והמאבחן. הזיכרונות צריכים להיות כלי אחד חשוב בתוך מערך כלי ההבנה, האבחון והטיפול השונים של המטפל על מנת להגיע להבנה מערכתית מבוססת עבר והווה, גורמים פנימיים וחיצוניים, גוף ונפש, חשיבה, רגש והתנהגות.

לצד זאת, ולמרות חשיבותם של הזיכרונות בעבודה הייעוצית והטיפולית, הם עדיין לא זכו להכרה המספקת והראויה להם באבחון ובפסיכותרפיה וכן במחקר הפסיכולוגי.

ביבליוגרפיה

שריג, ג' (2016). **שובל ילדות שקוף: על זיכרונות ילדות בגישה אדלריאנית**. תל-אביב: מכון מופ"ת.

Adler, A. ([1931]1964). Compulsion neurosis. In: H. Ansbacher & R. Ansbacher (Eds.), *Superiority and social interest: A collection of later writings* (pp. 112-138). Evanstone, Illinois: Northwestern University Press.

Adler, A. ([1931]1980). *What life should mean to you.* N.Y.: Perigee Books, Putnam's Sons.

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. *Archives of General Psychiatry*, *4*(6), 561-571.

Brown, C., & Augusta-Scott, T. (2007). *Narrative Therapy: Making meaning, making lives.* Sage Publications Inc. http://dx.doi.org/10.4135/9781452225869

Dwairy, M. (1997). A biopsychosocial model of metaphor therapy with holistic cultures. *Clinical Psychology Review*, *17*(5), 191-205.

Dwairy, M. (2013). A two-layers bio-psycho-social model of psychotherapy. *International Journal of Social and Behavioral Sciences, ISSN 2327-719X, 1*(4), 97-104.

Engler, B. (2008). *Personality theories.* 8th ed. Cengage Learning pub.

Erikson, E.H. (1959). *Identity and the Life Cycle.* N.Y.: International Universities Press.

Freud, S. ([1905]1949). *Three essays on the theory of sexuality.* London: Imago Pub. Co.

Freud, S. ([1915-1916]1981). The archaic features and infantilism of dreams. In: J. Strachey & A. Richards (Eds.), *Introductory lectures on psychoanalysis* (pp. 235-250). Penguin: Pelican Books.

Kosslyn, S.M. (1980). *Image and mind.* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Kosslyn, S.M. (1987). Seeing and imagining in the cerebral hemispheres: A computational approach. *Psychological Review*, *94*(2), 148–175.

Kosslyn, S.M., Thompson, W.L., & Ganis, G. (2006). *The case for mental imagery.* N.Y.: Oxford University Press, Inc.

Mahler, M.S., Pine, F., & Bergman, A. (2008). *The psychological birth of the human infant: Symbiosis and individuation*. Basic Books.

Racker, H. (2001). *Transference and counter-transference*. International Universities Press. ISBN 0-8236-8323-0.

Sacchi, D.L.M., Agnoli, F., & Loftus, E.F. (2007). Changing history: Doctored photographs affect memory for past public events. *Applied Cognitive Psychology, 21*(8), 1005-1022.

White, M., & Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends*. N.Y.: W.W. Norton. ISBN 978-0393700985

Winnicott, D.W. (1971). *Playing and reality*. London: Tavistock Publications.